

CAPÍTULO 1.14

Extrasístoles

PERFIL EUNACOM 1.01.1.011

Dx: Específico • Tx: Inicial • Seg: Derivar

Las **extrasístoles cardíacas** son latidos prematuros del corazón que se originan fuera del nódulo sinusal. Pueden ser auriculares o ventriculares y, en general, son hallazgos benignos en pacientes con corazón sano. Sin embargo, en pacientes cardíopatas, las extrasístoles ventriculares pueden indicar un mayor riesgo de arritmias más graves.

Extrasístoles Auriculares (ESA)

Las extrasístoles auriculares son latidos prematuros que se originan en las aurículas, fuera del nódulo sinusal.

Características Electrocardiográficas

- **QRS estrecho:** Es la característica más importante. El impulso se genera en las aurículas y se conduce a través del sistema de conducción normal (Haz de His, ramas, fibras de Purkinje), resultando en un QRS de morfología y duración normal.
- **Sin pausa compensatoria completa:** A diferencia de las extrasístoles ventriculares, el ritmo auricular se ve afectado, lo que significa que el siguiente latido sinusal puede ocurrir antes de lo esperado, y la suma del ciclo previo y posterior a la extrasístole no es igual a dos ciclos cardíacos normales.
- **Onda P prematura y de morfología diferente:** A menudo, se observa una onda P antes del QRS prematuro, pero su morfología es distinta a la de la onda P sinusal normal debido a su origen ectópico.

Diagnóstico

El diagnóstico se realiza mediante **electrocardiograma (ECG)**.

Tratamiento

- **Observación y educación:** En la mayoría de los casos, si el paciente tiene un corazón sano y las extrasístoles son un hallazgo incidental, el tratamiento consiste en la observación y en educar al paciente sobre la naturaleza benigna de la condición.
- **Manejo de síntomas:** Si el paciente presenta síntomas (palpitaciones, ansiedad), se pueden considerar medidas para reducir los desencadenantes (cafeína, estrés) o, en casos seleccionados, medicamentos.

Extrasístoles Ventriculares (EV)

Las extrasístoles ventriculares son latidos prematuros que se originan en los ventrículos.

Características Electrocardiográficas

- **QRS ancho:** Es la característica más importante. El impulso se origina en los ventrículos y se propaga de manera anómala a través del miocardio ventricular, lo que resulta en un QRS ensanchado (>0.12 segundos) y de morfología diferente a los latidos normales. La morfología puede variar (monomórficas, polimórficas).
- **Pausa compensatoria completa:** Es una característica distintiva. El intervalo entre el latido normal previo a la EV y el latido normal posterior a la EV (incluyendo la EV) es igual a la duración de dos ciclos cardíacos normales. Esto ocurre porque el ritmo sinusal no se ve alterado por la descarga ventricular prematura, y el nódulo sinusal sigue despolarizándose a su ritmo habitual.
- **Ausencia de onda P previa:** Generalmente, no hay una onda P precediendo a la EV, o si la hay, no tiene una relación de conducción con el QRS ancho.

Diagnóstico

El diagnóstico se realiza mediante **electrocardiograma (ECG)**.

Manejo de las Extrasístoles Ventriculares

El manejo depende fundamentalmente de la presencia de **cardiopatía estructural** y de la **sintomatología**.

Paciente con Corazón Sano

- **Observación:** Si el paciente no tiene cardiopatía estructural y las extrasístoles son un hallazgo incidental o causan síntomas leves, generalmente no requieren tratamiento específico. Se observa y se educa al paciente sobre su naturaleza benigna.

Paciente Cardiópata

- **Riesgo:** En pacientes con cardiopatía estructural (ej. **Insuficiencia Cardíaca: Generalidades** | **insuficiencia cardíaca**, cardiopatía isquémica post-infarto), especialmente si presentan una alta carga de extrasístoles ventriculares, existe un mayor riesgo de desarrollar arritmias ventriculares más graves, como la **taquicardia ventricular**.
- **Tratamiento antiarrítmico:**
 - **Betabloqueadores:** Son la primera línea de tratamiento. Ayudan a reducir la frecuencia de las extrasístoles y a disminuir el riesgo de arritmias más complejas.
 - **Amiodarona:** Puede ser utilizada en casos seleccionados, especialmente si los betabloqueadores no son efectivos o están contraindicados, o si hay un riesgo elevado de arritmias malignas.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En pacientes **cardiópatas**, las extrasístoles ventriculares no son un hallazgo benigno y deben ser evaluadas y manejadas activamente para prevenir la progresión a arritmias ventriculares potencialmente mortales.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Diferencias clave en el ECG: - **Extrasístole Auricular:** QRS estrecho, sin pausa compensatoria completa. - **Extrasístole Ventricular:** QRS ancho, con pausa compensatoria completa.

En resumen, las extrasístoles son comunes y a menudo benignas. La clave para su manejo radica en la diferenciación entre extrasístoles auriculares y ventriculares, y en la evaluación del estado cardíaco subyacente del paciente.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 35 años sana consulta por palpitaciones intermitentes tipo 'salto' que aumentan con el café y el estrés. Examen físico normal. ECG muestra latidos prematuros aislados con QRS angosto precedidos de onda P diferente al ritmo sinusal."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Las extrasístoles auriculares aisladas en pacientes jóvenes sin cardiopatía estructural son benignas y no requieren tratamiento antiarrítmico. Manejo: tranquilizar al paciente, reducir gatillantes (cafeína, estrés). Derivar a cardiología si son frecuentes ($> 10\%$ del total de latidos en Holter) o hay síntomas significativos.

NOTA CLÍNICA

La **pausa compensatoria completa** se explica porque la extrasístole ventricular no despolariza el nódulo sinusal retrógradamente. Por lo tanto, el nódulo sinusal sigue su ritmo normal, y el siguiente latido sinusal se produce a su tiempo, pero encuentra los ventrículos en período refractario debido a la extrasístole, lo que retrasa la activación ventricular efectiva.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Las ESV en corazón estructuralmente normal son generalmente benignas
- El bigeminismo es la alternancia de un latido sinusal con una ESV
- Los antiarrítmicos clase IC están contraindicados en ESV post infarto (estudio CAST)
- Las ESV que representan más del 15-20% de los latidos pueden causar taquicardiomiopatía
- Los betabloqueadores son primera línea cuando las ESV son sintomáticas
- Las ESV polimórficas son de mayor riesgo que las monomórficas
- El fenómeno R sobre T es de riesgo porque puede desencadenar TV o FV

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (EXTRASÍSTOLES)**PREGUNTA 1**

Paciente de 30 años, sano, consulta por palpitaciones. Holter muestra 8000 ESV monomórficas en 24 horas (8% del total). Ecocardiograma normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Iniciar amiodarona
- B)** Ablación por catéter urgente
- C)** Tranquilizar al paciente, betabloqueadores si es muy sintomático
- D)** Estudio electrofisiológico
- E)** Implante de DAI

PREGUNTA 2

Paciente post infarto de miocardio con ESV frecuentes. Se inicia encainida (antiarrítmico clase IC) para suprimirlas. Según la evidencia, ¿qué efecto se espera?

- A)** Reducción de mortalidad
- B)** Reducción de ESV sin efecto en mortalidad
- C)** Aumento de mortalidad
- D)** Sin efecto sobre ESV ni mortalidad
- E)** Mejoría de la función ventricular

PREGUNTA 3

Paciente con ESV monomórficas frecuentes (22% del total en Holter) y FEVI que ha disminuido de 60% a 40% en 6 meses. ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento más adecuado?

- A)** Miocardiopatía dilatada idiopática, iniciar IECA y betabloqueador
- B)** Taquicardiomiopatía por ESV, ablación del foco ectópico
- C)** Cardiopatía isquémica, coronariografía
- D)** Iniciar amiodarona para suprimir ESV
- E)** Observar y repetir ecocardiograma en 6 meses

RESUMEN: EXTRASÍSTOLES

Las extrasístoles son latidos prematuros que se originan fuera del nodo sinusal. Pueden ser auriculares (ESA) o ventriculares (ESV). Son extremadamente frecuentes y en la mayoría de los casos son benignas, especialmente en corazones estructuralmente normales. Sin embargo, en presencia de cardiopatía estructural, las ESV pueden tener significado pronóstico. Las extrasístoles auriculares se originan en las aurículas y tienen morfología de onda P diferente a la sinusal, seguida de QRS generalmente angosto. Las extrasístoles ventriculares se originan en los ventrículos y tienen QRS ancho con morfología aberrante, seguidas de una pausa compensadora completa. Se clasifican según frecuencia (aisladas, bigeminismo, trigeminismo), morfología (monomórficas o polimórficas) y complejidad (parejas, tripletas). En pacientes sin cardiopatía estructural, las ESV son generalmente benignas y no requieren tratamiento específico, solo tranquilización. Cuando son muy sintomáticas, los betabloqueadores son primera línea. La ablación se considera cuando las ESV representan más del 15-20% del total de latidos y causan disfunción ventricular (taquicardiomiopatía). En presencia de cardiopatía estructural, las ESV frecuentes requieren evaluación con ecocardiograma y eventualmente Holter para estratificación de riesgo.